Mentor Salud

PLAN DE ACCIÓN

Dra. Katia Alejandra Rivera Calderón
Médico Neumóloga CE 12440550
Alta especialidad en medicina del sueño

La siguiente información, es una guía rápida y accesible que le permite al paciente y a su médico tratante tomar decisiones con respecto al tratamiento y control de la enfermedad. Procure seguirlas y llevarlas con usted a todas partes.

Información para pacientes

Datos del paciente: .....

Nombre del paciente: ..... **Edad:** .....

Médico tratante: ..... **Teléfono de emergencia:** .....

Alergias: .....

Recomendaciones generales:

- Tome sus medicamentos prescritos como se indica — SIN RETRASO.
- Recuerde que el asma es una **enfermedad inflamatoria crónica,** por eso **no deje de tomar diariamente el tratamiento de mantenimiento o habitual** y a las dosis acordadas; aun cuando se sienta bien es necesario utilizar sus medicamentos del diario para mantener su asma en buen control
- y prevenir crisis o ataques de asma.
- **No fume,** ni esté en presencia de otras personas fumando.
  Si pierde el control de su asma, ¡actúe!, si dispone de un plan de acción, aplíquelo; si no, solicite ayuda médica.
- Si padece alergia (ácaros, mascotas, pólenes, etc), evite su exposición.
- Recuerde que este plan debe ser revisado y ajustado por su médico regularmente.
- Siempre lleve consigo el inhalador de rescate.

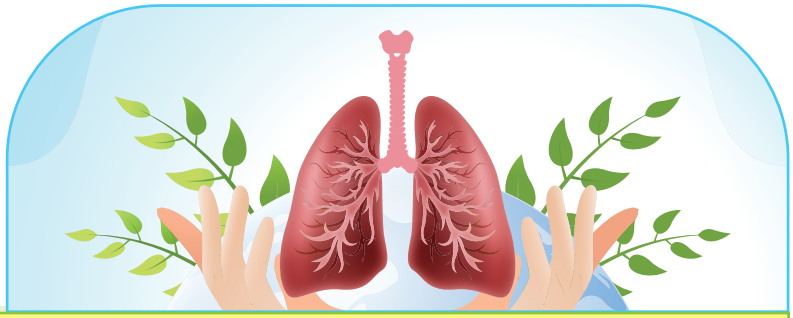
Tratamiento de mantenimiento o habitual:		
Nombre del medicamento:	**Dosis:**	**Frecuencia:**
Tratamiento broncodilatador de rescate:		
Nombre del medicamento:	**Dosis / dosis máxima:**	**Frecuencia:**
¿Cómo actuar?		
Flujometría	**Síntomas**	**Acciones**
Zona Verde: Buen Control PEF mayor del 80% del mejor valor personal (_____)	• Sin tos, silbidos, falta de aire ni opresión en el pecho. • Actividad física normal.	• Continuar con el tratamiento de mantenimiento.
Recomendaciones: evitar desencadenantes conocidos (alérgenos, irritantes, etc.).		
Zona Amarilla: Advertencia PEF entre 50-80% del mejor valor personal (_____)	**Síntomas** • Tos. • Sibilancias. • Dificultad leve para respirar. • Opresión en el pecho.	• Administrar el medicamento broncodilatador de rescate.

Recomendaciones:

- Si no mejora en 1 hora, **aumentar dosis de medicación de mantenimiento o habitual** según indicaciones médicas.
- Contactar al médico si los síntomas persisten o empeoran.

Mentor Salud

PLAN DE ACCIÓN



¿Cuándo debe incrementar su tratamiento habitual?:

¿Tiene síntomas de asma más de 2 veces al día?	Sí	No
¿Su actividad o ejercicio físico se encuentra limitado por el asma?	Sí	No
¿Le despierta el asma por la noche?	Sí	No
¿Necesita tomar su broncodilatador (rescate) más de 2 veces al día?	Sí	No
Si utiliza su medidor de flujo (PEF), ¿los valores son inferiores a _____?	Sí	No

Si ha respondido **Sí** en **3 o más de las preguntas**, su asma no se encuentra bien controlada y es necesario **aumentar su tratamiento habitual.**

¿Cómo se incrementa el tratamiento?

Nombre del medicamento: **Dosis:** **Frecuencia:**

Mantenga este tratamiento durante _____ días.

Zona Roja:		
Emergencia PEF menor del 50% del mejor valor personal (_____).	• Dificultad grave para respirar. • Incapacidad para realizar actividades normales. • Labios o uñas azulados. • La crisis es tan grave que sólo le permite hablar con frases cortas. • Si tiene que utilizar su broncodilatador de rescate cada 4 horas y no mejora.	• Llamar al 911 o acudir al servicio de urgencias. **En lo que llega con su médico/ hospital:** • Aplique 2 a 4 disparos de _____ cada _____ min. • Tome ___ tabletas de _____ de ___ mg por vía oral. Continúe usando su broncodilatador de rescate hasta que consiga la ayuda médica*.

Referencias bibliografías:

GEMA. (2024). *Guía GEMA 5.4. Asma* (versión 5.4). Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR).

Global Initiative for Asthma (GINA). (2024). *Global strategy for asthma management and prevention* (2024 update). Global Initiative for Asthma.